TÉCNICA DE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

1. Medición de la presión arterial en consulta

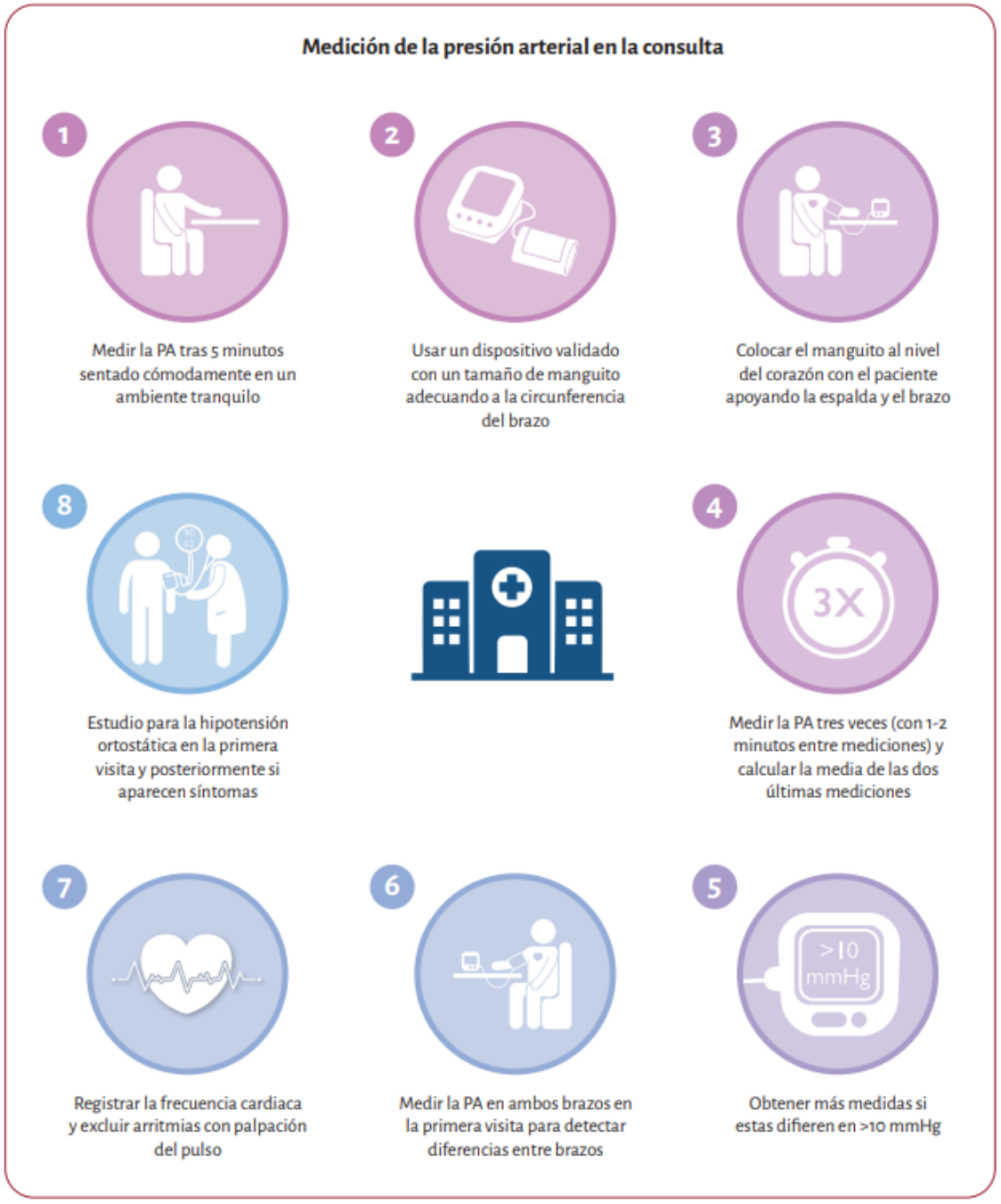


Imagen tomada de: Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión (Figura 3, Pág.21)

Preparación del paciente:

- ✓ La PA debe medirse con el paciente sentado cómodamente tras 5 minutos de reposo.
- ✓ Los pacientes deben evitar el ejercicio y los estimulantes (cafeína, tabaco) al menos 30 minutos antes de la medición.
- ✓ Si fuese necesario, el paciente puede vaciar la vejiga.
- ✓ Los pacientes deben sentarse sin cruzar las piernas y con la espalda apoyada en el momento de la medición.
- ✓ El brazo debe estar apoyado (para evitar los aumentos de la PA isométricos inducidos por el ejercicio).
- ✓ Se debe retirar la ropa en el lugar donde se coloque el manguito; se debe evitar remangar las mangas ya que puede provocar un efecto torniquete

Selección y posicionamiento del manguito:

- ✓ Se debe emplear un manguito de tamaño adecuado, ya que un manguito demasiado grande o demasiado pequeño elevará o reducirá artificialmente la PA, respectivamente.

- ✓ El manguito debe colocarse en la parte superior del brazo del paciente, al nivel del corazón, con el borde inferior del manguito unos centímetros por encima de la fosa ante cubital. El estetoscopio no se debe situar bajo el manguito.

Medición automática de la PA por auscultación manual:

- ✓ Se deben tomar tres mediciones de la PA, con un tiempo de 1-2 minutos entre cada una, y mediciones adicionales solo si las medidas difieren en >10 mmHg (p. ej., esto puede ocurrir en las arritmias o en la hipertensión de bata blanca). La PA se debe registrar como la media de las dos últimas medidas de la PA.

Diferencia entre brazos:

- ✓ En la primera visita, la PA debe medirse en ambos brazos para detectar diferencias entre brazos.
- ✓ La medición en el brazo contralateral debe llevarse a cabo una vez hayan finalizado las tres mediciones en el primer brazo y, si se detecta una diferencia, está indicado llevar a cabo más mediciones en el primer brazo para asegurarse de que la diferencia es consistente.
- ✓ Si la PA sistólica difiere en >10 mmHg entre los brazos, se deben obtener más mediciones en el brazo con los valores de PA más elevados. Las diferencias significativas entre brazos pueden ser el resultado de estenosis arterial o coartación de aorta, lo que requeriría más estudios.
- ✓ En algunos pacientes, se prefiere un brazo a otro para la medición rutinaria de la PA (p. ej., para evitar la medición de la PA en un brazo con una fístula arteriovenosa o un brazo en el que se haya realizado una disección de los ganglios linfáticos).

VIGILADO Supersalud

2. Medición Arterial en Domicilio (AMPA)

AMPA es un método de medición de la presión arterial fuera de la consulta en el que el paciente mide su propia PA en el domicilio utilizando un dispositivo validado (generalmente un dispositivo oscilo métrico con manguito para la parte superior del brazo). Se debe asesorar a los pacientes para que sigan los mismos pasos de preparación que en la consulta.



Imagen tomada de: Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión (Figura 4, Pág.22)

- ✓ Se deben tomar dos mediciones por sesión, con un intervalo de 1-2 minutos. Las medidas se deben llevar a cabo dos veces al día (mañana y tarde), a la misma hora y durante un mínimo de 3 días y un máximo de 7 días.

3. Medición ambulatoria de la presión arterial (MAPA)

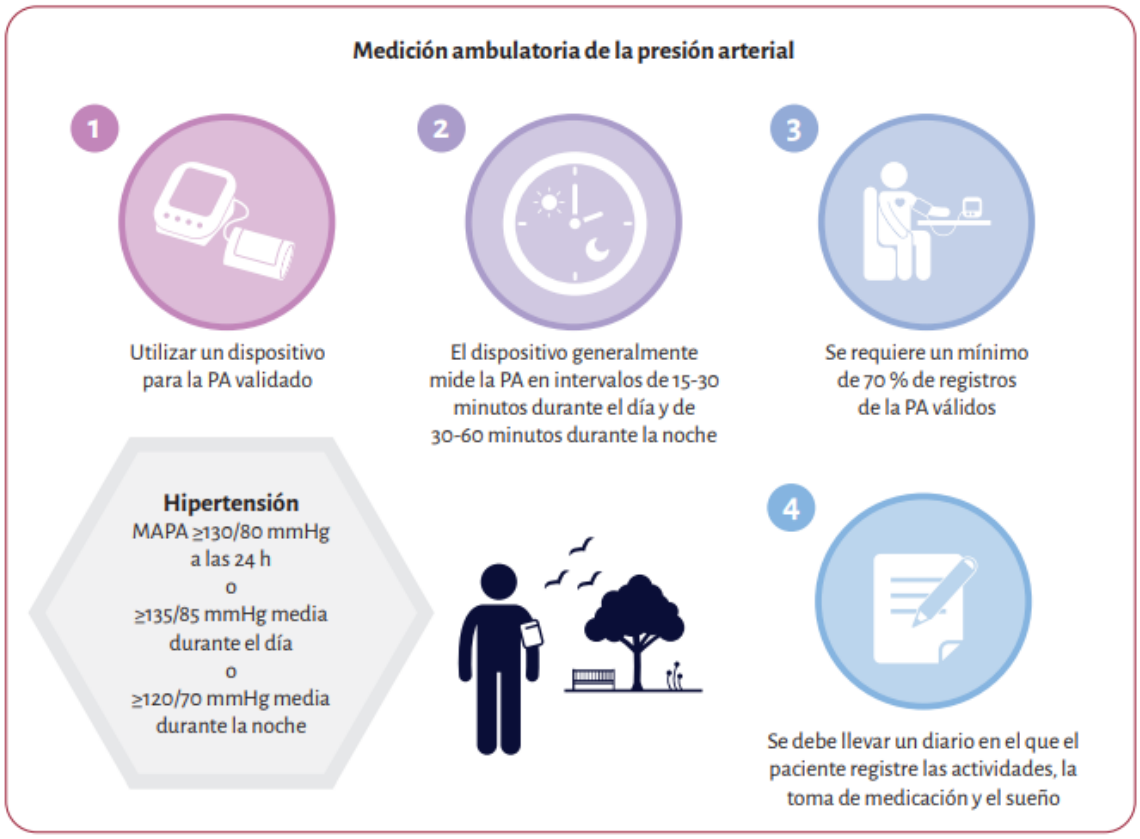


Imagen tomada de: Guía ESC 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión (Figura 5, Pág.23)

- ✓ MAPA es una medición de la PA fuera de la consulta en la que se utiliza un dispositivo totalmente automatizado, generalmente durante un periodo de 24 h. Estos dispositivos miden la PA utilizando el método oscilo métrico y están programados para medir la PA en intervalos fijos.

- ✓ Las lecturas se suelen obtener cada 15-30 minutos durante el día (generalmente de 7 a.m. a 11 p.m.) y cada 30-60 minutos durante la noche (generalmente de 11p.m. a 7 a.m.). El software aporta las medias de PA para el día, la noche y a las 24 h. Se requiere un mínimo de 70 % de registros validados para una sesión de medida válida, lo que suele equivaler a ≥27 medidas a las 24 y siete lecturas nocturnas.

- ✓ Se debe llevar un diario de las actividades (p. ej., comidas y ejercicio) y del tiempo de sueño para ayudar a la interpretación.